

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Pediátrica —

PACIENTE

Isabella María Cardona Mejía

DOCUMENTO

TI 1121000005

FECHA NACIMIENTO

25/03/2010

EDAD

16 años, 2 meses

SEXO

Femenino

ESCOLARIDAD

10° Secundaria

LATERALIDAD

Diestra

FECHA DE EVALUACIÓN

08/06/2026

ORDEN N°

OM-2026-001238

PROTOCOLO APLICADO

WISC-IV + CDI + Spence

ELABORADO POR

Profesional admin-read

Psicólogo

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	Isabella María Cardona Mejía	Lateralidad:	Diestra
Documento:	TI 1121000005	Ocupación:	Estudiante
Fecha de nacimiento:	25/03/2010	Ciudad:	Bogotá, D.C.
Edad:	16 años, 2 meses	Acompañante:	Roberto Cardona Salazar
Sexo:	Femenino	Remite:	Psicóloga colegio
Escolaridad:	10° Secundaria	EPS / Asegurador:	Compensar EPS

MOTIVO DE CONSULTA

Síntomas depresivos de 4 meses de evolución: tristeza persistente, anhedonia, aislamiento, bajo rendimiento académico. Síntomas ansiosos: preocupación excesiva, insomnio, quejas somáticas.

HISTORIA DEL DESARROLLO

Hitos relevantes en la trayectoria evolutiva

Perinatales y prenatales

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

Trayectoria escolar

Estudios: 10° Secundaria. Ocupación: Estudiante.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: WISC-IV + CDI + Spence

Prueba	Dominio	Dur.
Diseño con Cubos	Razonamiento Perceptual	—
Semejanzas	Comprensión Verbal	—
Vocabulario	Comprensión Verbal	—
Claves	Velocidad de Proceso	—
Regresión Dígitos Directos	Memoria de Trabajo	—
Ind Comp Verb	Índice CI	—
Ind Raz Perce	Índice CI	—
Ind Mem Trab	Índice CI	—
Ind Vel Proce	Índice CI	—
CI total	Inteligencia General	—
CDI Escala de depresión	Socioemocional - Depresión	—
PAS Total	Socioemocional - Ansiedad	—

ANTECEDENTES

Patológicos / Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Sin antecedentes psiquiátricos previos.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Niega TEC previo.

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica completa. Paciente colaborador. Sin incidentes durante la aplicación.

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Emociones y comportamiento

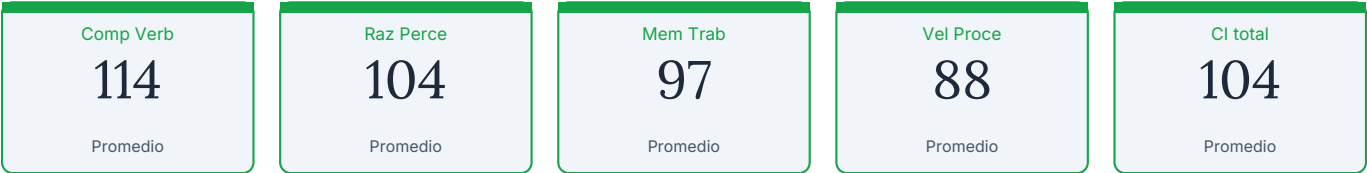
Tristeza persistente, llanto fácil. Anhedonia: 'ya nada me gusta'. Pensamientos de minusvalía. Sin ideación suicida activa.

Cociente intelectual (observación)

Perfil cognitivo global: F32.1 - Episodio depresivo moderado + F41.1 - Ansiedad generalizada

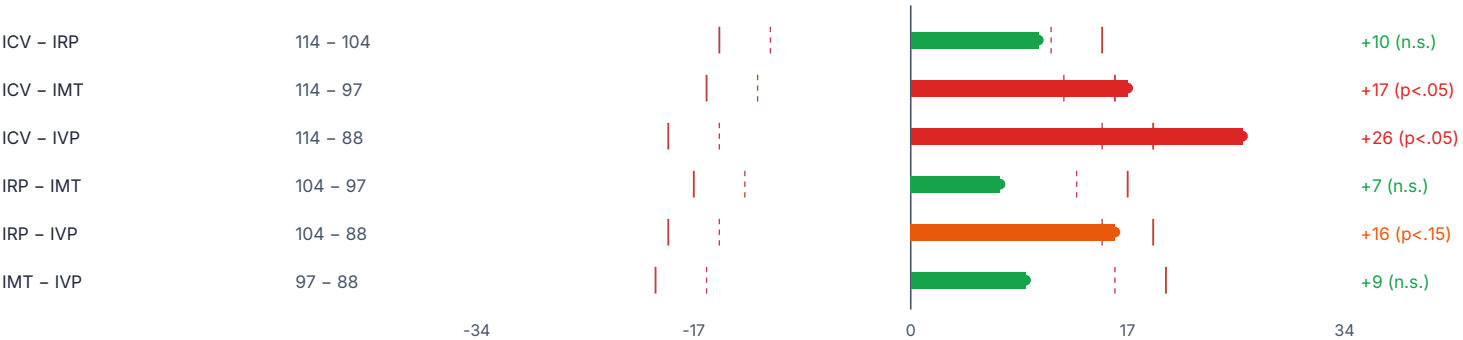
RESULTADOS CUANTITATIVOS

Puntajes estandarizados y perfil cognitivo

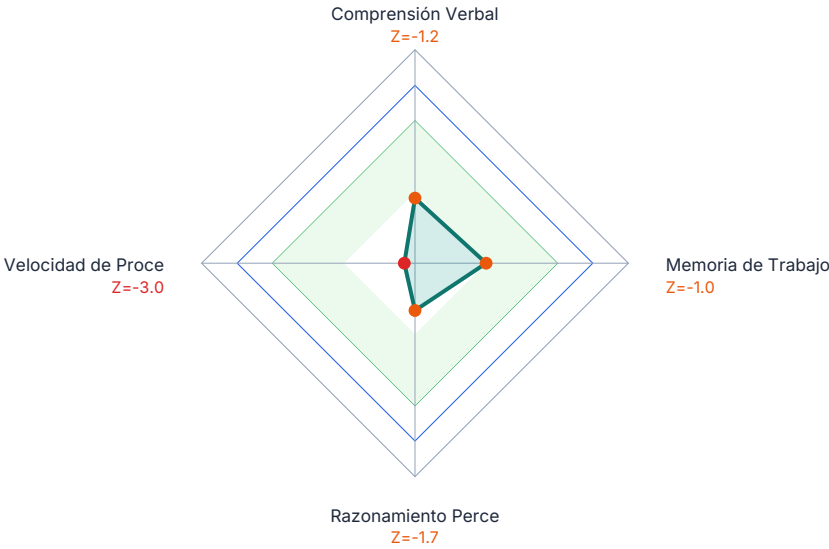


Discrepancias entre índices

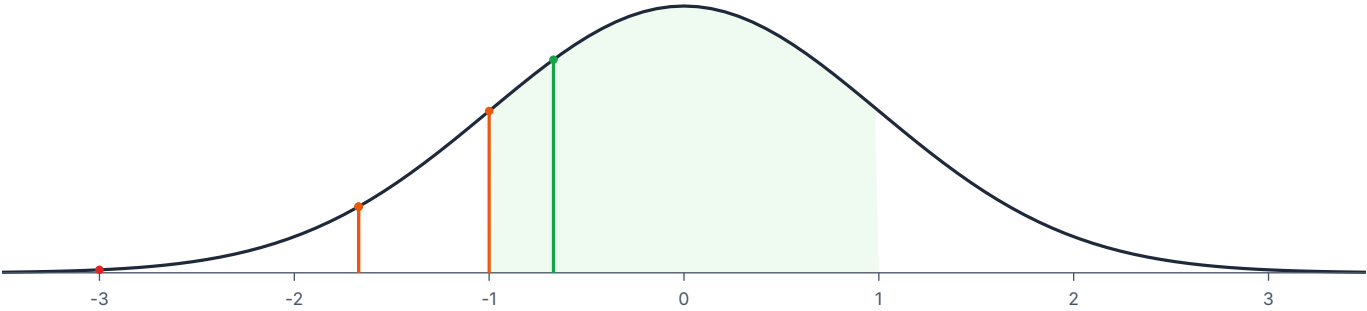
Diferencia = valor del primer índice - segundo. Líneas críticas según Wechsler ($p<.15$... y $p<.05$).



Perfil cognitivo por dominio



Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar n = 5 pruebas con norma disponible



Perfil Z por prueba

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
Diseño con Cubos							-1.67
Semejanzas							-0.67
Vocabulario							-1.67
Claves							-3.00
Regresión Dígitos Directos							-1.00
Ind Comp Verb							+0.93
Ind Raz Perce							+0.27
Ind Mem Trab							-0.20
Ind Vel Proce							-0.80
CI total							+0.27

Banda verde = rango normal (-1 a +1 σ). Z<-1 sugiere debilidad. Z>+1 sugiere fortaleza relativa.

Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
Diseño con Cubos	30	5	-1.67	Limitrofe
Semejanzas	25	8	-0.67	Promedio
Vocabulario	32	5	-1.67	Limitrofe
Claves	28	1	-3.00	Bajo
Regresión Dígitos Directos	15	7	-1.00	Promedio
Ind Comp Verb	38	114	+0.93	Promedio

Prueba	PD	Escala/CI	Z	Interpretación
Ind Raz Perce	32	104	+0.27	Promedio
Ind Mem Trab	19	97	-0.20	Promedio
Ind Vel Proce	16	88	-0.80	Promedio
CI total	105	104	+0.27	Promedio
CDI Escala de depresión	22	—	—	Sin dato
PAS Total	65	—	—	Sin dato

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

Isabella obtuvo un Cociente Intelectual Total (CIT) de 104, ubicándose en la categoría promedio (percentil aproximado 61). Se observa una variabilidad relevante entre sus índices compuestos: el más bajo corresponde a IVP (88) y el más alto a ICV (114), lo que sugiere un perfil asimétrico que conviene analizar por separado más que resumir en una única puntuación global.

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: velocidad de proceso (severamente disminuido, $Z=-3.0$); razonamiento perceptual (moderadamente disminuido, $Z=-1.7$); comprensión verbal (moderadamente disminuido, $Z=-1.2$); memoria de trabajo (moderadamente disminuido, $Z=-1.0$).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran Claves ($Z=-3.00$, bajo); Diseño con Cubos ($Z=-1.67$, límite); Vocabulario ($Z=-1.67$, límite). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Áreas con desempeño disminuido

- Claves — bajo ($Z=-3.00$)
- Diseño con Cubos — límite ($Z=-1.67$)
- Vocabulario — límite ($Z=-1.67$)
- Regresión Dígitos Directos — promedio ($Z=-1.00$)

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Isabella. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En NiWiscSem, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En NiWiscRDD, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En NiWISCIndComVer, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. Las áreas donde se recomienda trabajar incluyen: En NiWiscCI, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.

Áreas para apoyar (en qué trabajar)

- En NiWiscSem, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En NiWiscRDD, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En NiWISCIndComVer, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En NiWISCIndRazPer, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En NiWISCIndMemTra, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En NiWiscCI, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.

¿Qué recomendamos?

Sobre la terapia: continúa con tus sesiones según lo acordado. Si tienes dudas, coméntalas con tu terapeuta.

Preguntas frecuentes

• ¿Mis resultados son permanentes?

No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica y los apoyos adecuados. Los resultados que obtuviste son una foto del momento actual.

• ¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?

Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto no significa que haya algo mal en ti.

• ¿Necesito otro tipo de evaluaciones?

Tu psicólogo/a te dirá si se necesitan otros estudios (por ejemplo, evaluación pedagógica, médica, o del lenguaje). No te preocupes si no entiendes algún término: puedes preguntar siempre.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

DSM-5 / CIE-10

Diagnóstico codificado

Código CIE-10: F32

Impresión diagnóstica: F32.1 - Episodio depresivo moderado + F41.1 - Ansiedad generalizada

RECOMENDACIONES

Plan de manejo agrupado por área y prioridad

- Se recomienda seguimiento clínico y plan terapéutico según hallazgos. Reevaluación en 6-12 meses si aplica.

ANEXO — DEFINICIONES OPERATIVAS

Convenciones interpretativas utilizadas en este informe

Cociente Intelectual (CI)

Puntuación estándar con media 100 y desviación 15. CIT menor a 70 sugiere déficit; 70-79 límite; 80-89 promedio bajo; 90-109 promedio; 110-119 promedio alto; 120-129 superior; ≥ 130 muy superior.

Puntaje escalar (PE)

Subtests Wechsler — media 10, desviación 3. PE de 8-12 equivale al rango promedio.

Puntuación Z

Desvío en unidades de desviación estándar respecto al grupo normativo. $Z = (PD - \mu) / \sigma$. $Z \leq -1$ indica rendimiento bajo el promedio; $Z \leq -2$ indica déficit clínico.

Percentil

Porcentaje de la población normativa con desempeño igual o inferior al del paciente.

Discrepancia significativa

Diferencia entre índices que excede el umbral de Wechsler. Líneas críticas: $p < .15$ (.....) sugieren tendencia; $p < .05$ () indican diferencia confiable.

Reliable Change Index (RCI)

Jacobson-Truax. $RCI > 1.96$ indica cambio confiable ($p < .05$) entre evaluaciones repetidas. Se reporta sólo en informes de seguimiento.